EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 90658
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-08-14 18:27:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: VICTORIA PAZ GONTUPIL PEREZ			RUN	: 16.844.875-9
F.Nac	: 19-02-1988	Edad	: 36 AÑOS, 5 MESES	Género	: Femenino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-08-05	Fecha Egreso	: 2024-08-14 18:27:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. R50.9-FIEBRE, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

INFECCION VIAS URINARIAS ALTA (PIELONEFRITIS AGUDA)
ANTECEDENTES: MENINGOCELE, VEJIGA NEUROGÉNICA, EPILEPSIA SECUNDARIA, RM, HIDROCEFALIA OP CON DVP

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. N39-OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

PACIENTE TRAÍDA POR FAMILIAR A SERVICIO DE URGENCIAS QUIEN REFIERE INICIO DE SINTOMATOLOGÍA HACE 2 DÍAS PRESENTANDO COMPROMISO DE CONSCIENCIA, ASOCIADO A DESORIENTACIÓN Y SOMNOLENCIA. FAMILIAR DESTACA DESDE HACE 1 SEMANA APROXIMADAMENTE DOLOR EN REGIÓN LUMBAR DERECHA, ASOCIADO A CAMBIO EN COLOR Y OLOR DE LA ORINA. RECIBIENDO NITROFURANTOÍNA COMO PROFILÁCTICO SECUNDARIO A VEJIGA NEURONÉGICA. EN VISTA DE CONDICIONES DECIDE ACUDIR A URGENCIAS, DONDE SE TOMAN SIGNOS VITALES DE INGRESO DESTACANDO TAQUICARDIA, HIPERTENSIÓN Y FIEBRE 39° COMO MÁXIMO.
DURANTE ESTANCIA EN SERVICIO SE TOMAN EXÁMENES DE LABORATORIO QUE REPORTAN:
PCR: 202.4 | GB: 10.900 / SE TOMAN HEMOCULTIVOS, PENDIENTE RESULTADO.

SE REALIZA TC AP C/C QUE REPORTA: SIGNOS DE PIELONEFRITIS AGUDA.
DURANTE LA VALORACIÓN DIRECTA DE TC IMPRESIONA ABSCESO RENAL DERECHO. SE SOLICITARÁ VALORACIÓN DIRIGIDA POR SERVICIO.
EX FÍSICO
PIEL: CAMBIOS Y SIGNOS PROPIOS DE LA EDAD. BUEN LLENADO CAPILAR.
TORAX: ASIMÉTRICO, FRANCA DESVIACIÓN ESCOLIÓTICA, MP+ ESCASOS ESTERTORES, RR2T SS.
ABD: RHA+, SIN MEGALIAS, PUÑO PERCUSIÓN ACTUALMENTE NEGATIVA.
EN VISTA DE CONDICIONES, SE DECIDE INGRESO.
EVALUADA POR CIRUGIA, REFIEREN IMÁGENES RENALES (DER) CON AREAS HIPODENSAS PERO SIN FORMACION DE COLECCIÓN SUGERENTE DE ABSCESO, SUGIERE TTO ATB PROLONGADO (21D)
PRESENTA EVOLUCION FAVORABLE, MEJORANDO ESTADO GENERAL Y PROGRESIVAMENTE DECENSO DE PARAMETROS INFLAMATORIOS, AFEBRIL,
A LOS 8 DIAS DE ATB CON LEUCOCITOS EN 5700 (SEGM 47%) Y PCR 17
HOY COMPLETA 10 DIAS CON CEFTRIAXONA 2G EV AL DIA, CON BUENA EVOLUCION, ASINTOMATICA,

BUEN AMINO, APETITO OK, BUENA TOLERANCIA A REHABILITACION KINESICA. POR LO QUE SE DECIDE SU TRASLADO A HODOM, PARA COMPLETAR TTO ATB.

PLAN DE MANEJO:

CONTROL POLI CIRUGIA DR INOSTROZA EN 20 DIAS (POR LESION RENAL A PRESENTAR A UROLOGIA, EVENTUAL NECESIDAD DE CONTROL CON PIELOTC)
CONTROL SOS VIA URGENCIAS

INDICACIONES AL ALTA

1. A HODOM
2. REPOSO RELATIVO
3. REGIMEN LIVIANO, LIQUIDOS ABUNDANTES
4. MANEJO DE VEJIGA NEUROGENICA CON SONDEO (MANEJO HABITUAL DE PCTE)
5. CEFTRIAXONA 2 GR AL DIA EV POR 10 DIAS MAS (COMPLETAR 21 DIAS)
6. PARACETAMOL 500MG 2 C/8 HRS SOS EN CASO DOLOR O FIEBRE VO
7. TRATAMIENTOS CRONICOS HABITUALES RETOMAR, VERIFICAR USO DE NITROFURANTOINA QUE REFIERE TIENE HACE AÑOS, NO USAR MIENTRAS ESTE CON TTO EV EN HODOM

EXÁMENES Y RESULTADOS

TAC CEREBRO: SIN LESIONES DE CARACTER AGUDO / DERIVACION VENTRICULAR
TAC TX SIN CTE: SIN HALLAZGOS DE SIGNIFICADO PATOLOGICO
TAC AP: HALLAZGOS DE PIELONEFRITIS DERECHA / PROBABLE MIOMA UTERINO/ ESCASO LIQ FDO DE SACO/ ESCOLIOSIS DEXTROCONVEXA

OMAR ULLOA GUTIERREZ
MEDICO TRATANTE
13102850-4

JEFE SERVICIO